Клинические рекомендации

Болезнь Меньера

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H81.0** — Болезнь Меньера
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/18_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 3

2.3 Клиническая картина 4

2.4 Стадии заболевания 4

2.5 Степень тяжести 5

2.6 Жалобы 5

3. Диагностика 5

3.1 Диагностические критерии 5

3.2 Физикальное обследование: акуметрия и вестибулярные пробы 6

3.3 Общий и биохимический анализы крови 6

3.4 Тональная аудиометрия и импедансометрия 6

3.5 Подтверждение гидропса лабиринта 6

3.6 Отоакустическая эмиссия и КСВП 7

3.7 Вестибулярные исследования 7

3.8 Лучевые методы исследования 7

3.9 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 8

4.1 Купирование приступа 8

4.2 Межприступный период 9

4.3 Хирургическое лечение 9

4.4 Медицинская реабилитация 9

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 10

5.1 Организация медицинской помощи 10

6. Источник и актуальность **10**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Достоверная болезнь Меньера:
  1. **не менее двух** спонтанных приступов головокружения длительностью **от 20 минут до 12 часов**;
  2. сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа;
  3. флюктуирующие слуховые симптомы: слух, шум, ощущение полноты в ухе;
  4. отсутствие других причин.
- Обследование всех пациентов:
  1. тональная пороговая аудиометрия: степень тугоухости;
  2. импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия): исключение патологии среднего уха.
- Купирование приступа:
  1. атропин или платифиллин подкожно;
  2. антигистаминные: дименгидринат, дифенгидрамин;
  3. бензодиазепины: лоразепам, диазепам.

  Не более **3 суток**; из-за тошноты и рвоты предпочтительно парентеральное введение.
- Межприступный период: бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки **2–3 месяца и более** после перенесённого приступа и при повторении приступов **чаще одного раза в 3 месяца**.
- Хирургическое лечение при неэффективности консервативного **в течение 6–12 месяцев**:
  1. первый этап: слухосохраняющие вмешательства;
  2. второй этап или социально незначимый слух: деструктивные вмешательства.
- Компьютерная томография (КТ) височных костей и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов выполняют для исключения новообразований, прежде всего акустической шванномы при односторонней сенсоневральной тугоухости.
- Лечение амбулаторное. Показания к госпитализации в оториноларингологическое отделение: тяжёлое состояние пациента или тяжёлое течение заболевания. Критерии выписки: урежение или прекращение приступов головокружения, улучшение или стабилизация порогов слуха.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Болезнь Меньера (БМ) является заболеванием внутреннего уха, которое характеризуется повторяющимися приступами системного головокружения, а также шумом в ушах и сенсоневральной тугоухостью.

2.2 Классификация

Формы по классификации AAO-HNS

1. несомненная;
2. достоверная;
3. вероятная;
4. возможная.

Варианты начала

1. кохлеарная форма: сначала слуховые расстройства, затем вестибулярные;
2. классический вариант: слуховые и вестибулярные нарушения одновременно, уже первый приступ сопровождается снижением слуха и шумом;
3. вестибулярная форма (реже): сначала приступы головокружения, слуховые расстройства позже.

По данным ряда авторов, флюктуация слуха в сочетании с головокружением наблюдается у 82,7% пациентов, без головокружения у 17,3%; по другим данным, заболевание начинается с изолированной кохлеарной симптоматики у 54,4% пациентов, с классической картины у 45,6%.

2.3 Клиническая картина

Триада

1. приступы системного головокружения;
2. шум в ухе;
3. тугоухость.

Приступ

1. развивается внезапно, в любое время, на фоне полного здоровья, ничем не провоцируется;
2. иногда предшествует аура: появление или усиление заложенности и шума в поражённом ухе;
3. всегда сопровождается вегетативными проявлениями, прежде всего тошнотой и рвотой;
4. длится несколько часов (чаще 4–6) и проходит самостоятельно, без препаратов;
5. шум в ухе односторонний, чаще низко- или среднечастотный, усиливается перед приступом и во время него.

Тугоухость, как правило, односторонняя и флюктуирующая. Её аудиологические признаки приведены в разделе «Диагностика» (тональная аудиометрия).

2.4 Стадии заболевания

Первая стадия (начальная)

1. приступы редкие: 1–2 раза в год или раз в 2–3 года, в среднем 1–3 часа, с тошнотой и рвотой;
2. шум, заложенность, распирание в ухе до или во время приступа, но не постоянно;
3. флюктуация слуха: ухудшение перед приступом и последующее улучшение; у некоторых пациентов слух резко улучшается сразу после приступа и снижается до прежнего уровня в течение суток.

Вторая стадия (разгар)

1. типичные приступы с интенсивным системным головокружением и выраженными вегетативными проявлениями;
2. частота: от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю или ежедневно;
3. постоянный шум в ухе, усиливающийся во время приступа;
4. ежедневная заложенность и дискомфорт в ухе;
5. слух снижается от приступа к приступу.

Третья стадия (затухающая)

1. типичные приступы урежаются или прекращаются;
2. постоянная шаткость и неустойчивость;
3. выраженное снижение слуха на поражённое ухо, часто вовлекается второе ухо;
4. возможны отолитовые кризы Тумаркина: внезапные падения вследствие резкого смещения отолитовых рецепторов, опасные травмами.

> Длительность приступа в тексте рекомендации указана неодинаково: в общем описании клинической картины она составляет несколько часов (чаще 4–6), для первой стадии в среднем 1–3 часа, в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.

2.5 Степень тяжести

Степени тяжести (частота и длительность приступов, трудоспособность)

1. тяжёлая: приступы ежедневные или еженедельные, по несколько часов, со всем комплексом статокинетических и вегетативных расстройств; трудоспособность утрачена;
2. средняя: приступы еженедельные или ежемесячные, по несколько часов, статокинетические расстройства умеренные, вегетативные выражены; трудоспособность утрачивается во время приступа и на несколько часов после;
3. лёгкая: приступы непродолжительные, ремиссии месяцы и годы.

2.6 Жалобы

Жалобы

1. приступы нарастающей глухоты;
2. шум в ушах;
3. периодическая потеря равновесия;
4. головокружение;
5. тошнота вплоть до рвоты.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают по одной из систем критериев:

1. AAO-HNS (1972, 1985, 1995);
2. критерии 2015 года, согласованным Обществом Барани, Европейской академией отологии и нейроотологии (EAONO), комитетом по равновесию AAO-HNS и Корейским обществом равновесия.

3.1 Диагностические критерии

Форма	Критерии
Несомненная	1. гистологически подтверждённый эндолимфатический гидропс; 2. не менее двух приступов головокружения от 20 минут до 12 часов; 3. сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; 4. флюктуирующие слуховые симптомы: слух, шум, ощущение полноты в ухе.
Достоверная	1. не менее двух спонтанных приступов головокружения от 20 минут до 12 часов; 2. сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; 3. флюктуирующие слуховые симптомы; 4. отсутствие других причин.
Вероятная	1. не менее одного приступа головокружения; 2. сенсоневральная тугоухость, подтверждённая хотя бы однократной аудиометрией; 3. шум или заложенность в поражённом ухе; 4. отсутствие других причин.

Форма	Критерии
Возможная	1. приступы головокружения без подтверждённого снижения слуха либо стойкая или непостоянная сенсоневральная тугоухость с нарушением равновесия без явных приступов; 2. отсутствие других причин.

3.2 Физикальное обследование: акуметрия и вестибулярные пробы

Комплексное общеклиническое обследование с участием терапевта и невролога.

Методы исследования

1. акуметрия: шёпотная и разговорная речь, камертональные пробы Вебера, Ринне и Федериче;
2. оценка спонтанного нистагма;
3. тест импульсного поворота головы (Хальмаги–Кертойза);
4. статокоординаторные и статокинетические пробы: поза Ромберга, проба Фишера–Барре, ходьба по прямой и фланговая походка, проба на диадохокинез;
5. позиционные пробы: Дикса–Холлпайка, roll-тест Пагнини–Макклюра.

3.3 Общий и биохимический анализы крови

Показания

1. дифференциальная диагностика.

Выполняют общий (клинический) и биохимический общетерапевтический анализы крови.

3.4 Тональная аудиометрия и импедансометрия

Показания: все пациенты

1. тональная пороговая аудиометрия: определение степени тугоухости;
2. импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия): исключение патологии среднего уха.

Диагностические признаки

1. скалярная (ложная сенсоневральная) тугоухость: горизонтальный или восходящий тип кривой с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах;
2. пороги восприятия ультразвука в норме, латерализация ультразвука в сторону хуже слышащего уха;
3. возможно снижение амплитуды пиков спонтанной отоакустической эмиссии.

При ретрокохлеарном уровне поражения отмечается повышение порогов акустического рефлекса относительно нормальных порогов слышимости.

3.5 Подтверждение гидропса лабиринта

Показания к подтверждению гидропса лабиринта

1. клинические признаки вероятной болезни Меньера;
2. неэффективность консервативной терапии.

Методы (по отдельности или в сочетании)

1. пороги чувствительности к ультразвуку и его латерализация;
2. электрокохлеография (ЭКоГ);
3. дегидратационный тест.

Универсального метода выявления гидропса лабиринта не существует. Для подтверждения диагноза необходим широкий спектр исследований с оценкой результатов в динамике, при этом результаты в значительной степени зависят от стадии заболевания.

3.6 Отоакустическая эмиссия и КСВП

Показания к отоакустической эмиссии и коротколатентным слуховым вызванным потенциалам (КСВП)

1. противопоказания к МРТ головного мозга (например, металлические конструкции);
2. сомнительные результаты тональной аудиометрии: подозрение на аггравацию или симуляцию.

Критериями ретрокохлеарной дисфункции по данным КСВП являются отсутствие всех пиков с I по V, которое трудно объяснить потерей слуха; отсутствие всех пиков, следующих за I или III; удлинение межпикового интервала I–V более 4,4 мс; снижение отношения амплитуд V/I менее 0,5, особенно в сочетании с другими изменениями. Диагностическое значение имеет также патологически большая межауральная разница параметров, особенно межпиковых интервалов, если её трудно объяснить односторонней или асимметричной тугоухостью периферического уровня.

3.7 Вестибулярные исследования

Показания

1. диагноз невозможно установить по клиническим данным;
2. планирование хирургического лечения.

Межприступный период

1. спонтанной вестибулярной симптоматики нет;
2. статическое и динамическое равновесие в норме, в том числе по постурографии (стабилографии);
3. при вестибулометрии угнетение вестибулярной функции, больше на стороне поражения.

Приступ: периферический вестибулярный синдром

1. системное головокружение;
2. тошнота, рвота;
3. нарушение равновесия;
4. горизонтальный вестибулярный нистагм.

Показания к видеонистагмографии (ВНГ)

1. дифференциальная диагностика;
2. планирование хирургического лечения.

Запись калорической или вращательной пробы, видеоимпульсного и других тестов.

3.8 Лучевые методы исследования

Показаны КТ височных костей и МРТ головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов, в том числе с контрастированием.

Цель: исключить

1. новообразования, при односторонней сенсоневральной тугоухости прежде всего акустическую шванному;
2. демиелинизирующий процесс;
3. нейроваскулярный конфликт;
4. приобретённые и врождённые структурные изменения височных костей.

3.9 Дифференциальная диагностика

Диагноз	Отличительные признаки
Болезнь Меньера	Приступы системного головокружения, сопровождающиеся снижением слуха, ощущением распирания и шумом в ухе, тошнотой и рвотой

Диагноз	Отличительные признаки
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)	Кратковременные приступы системного головокружения, возникающие при изменении положения тела
Вестибулярный нейронит	Резко выраженное вращательное головокружение, расстройство равновесия, тошнота и рвота на фоне вирусной инфекции
Перилимфатическая фистула	Головокружение различной степени выраженности и нарушения слуха вплоть до глухоты после травмы уха или на фоне хронического отита; симптомы провоцируются изменением давления или громкими звуками
Инфаркт лабиринта	Острое системное головокружение, часто в сочетании с острой односторонней глухотой и шумом в ухе
Аутоиммунные заболевания внутреннего уха	Прогрессирующее головокружение преимущественно вестибулярного характера с двусторонним снижением слуха и другими признаками аутоиммунного заболевания
Вестибулярная мигрень	Мигренозная головная боль при части приступов головокружения

4. Лечение

Лечение включает три направления: медикаментозное купирование приступа головокружения, медикаментозную профилактику в межприступном периоде и хирургическое лечение.

4.1 Купирование приступа

1. #Атропин или #платифиллин подкожно: блокируют афферентную импульсацию от раздражённого лабиринта. Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции.
2. Для купирования приступа применяют дименгидринат или дифенгидрамин.
   Препараты относятся к Н1-антигистаминным средствам, проникают через гематоэнцефалический барьер и действуют как вестибулярные блокаторы центрального действия. Их используют в первые сутки приступа, максимально **до 3 суток**.
3. Назначают #лоразепам или #диазепам в первые сутки, **максимально до 3 суток**.
   Ввиду тошноты и рвоты во время приступа предпочтительно парентеральное введение препаратов; по мере купирования симптомов возможен переход на таблетированные формы.

Препарат	Доза
#Атропин	1 мл 0,1% раствора подкожно
#Платифиллин	2 мл 0,2% раствора подкожно
Дименгидринат	50–100 мг 2–3 раза в сутки
Дифенгидрамин	25–50 мг внутрь 3–4 раза в сутки; внутримышечно — #дифенгидрамин 10–50 мг
#Лоразепам	1 мг, возможно сублингвальное применение
#Диазепам	10 мг внутримышечно

4.2 Межприступный период

Бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки (48 мг в сутки), курс **2–3 месяца и более**.

Показания

1. после перенесённого приступа головокружения;
2. межприступный период **менее 3 месяцев**.

Бетагистин улучшает кровообращение в сосудистой полоске внутреннего уха, снижает возбудимость нейронов вестибулярных ядер и ускоряет восстановление вестибулярной функции, в том числе за счёт активации центральной вестибулярной компенсации.

Назначают курсами диуретики (калийсберегающие, тиазидные и другие) или ингибиторы карбоангидразы, оптимально ацетазоламид. Петлевые диуретики не применяются ввиду возможного ототоксического действия.

Пример схемы ацетазоламида из рекомендации

1. 1–3-й день: по 1 таблетке 2 раза в день (утром и днём);
2. 7–9-й и 13–15-й дни: по 1 таблетке утром.

Курс подбирают индивидуально.

При длительном приёме ацетазоламида следует контролировать уровень электролитов крови и при необходимости восполнять их.

Диетотерапия всем пациентам:

1. поваренная соль **до 2 г в сутки**;
2. исключение глутамата натрия;
3. сбалансированное питание для нормализации водно-солевого обмена.

Потребление соли и готовых продуктов следует максимально ограничить, алкоголь, кофеин и никотин исключить, жидкость потреблять умеренно.

Плановую инфузионную дегидратационную терапию проводят в первые 2 года заболевания **каждые 6–12 месяцев**, затем **каждые 2–3 года**. Конкретные препараты в рекомендации не указаны.

4.3 Хирургическое лечение

Показание: неэффективность консервативной терапии **в течение 6–12 месяцев**.

Первый этап: слухосохраняющие вмешательства (I и II стадии)

1. хордоплексустомия;
2. интратимпанальное введение глюкокортикоидов;
3. обнажение (дренирование) эндолимфатического мешка;
4. селективная лазеродеструкция ампулярного рецептора горизонтального полукружного канала.

Второй этап: деструктивные вмешательства

1. интратимпанальное введение гентамицина;
2. лазеродеструкция лабиринта;
3. вестибулярная нейроэктомия.

Показания: неэффективность слухосохраняющей операции или социально незначимый слух.

4.4 Медицинская реабилитация

1. нарушение равновесия в межприступном периоде на третьей стадии: лечебная физкультура;
2. двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость со средними порогами в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе **выше 31 дБ**: слухопротезирование.

При развитии соматоформных расстройств на фоне хронической вестибулярной дисфункции показана психолого-социальная реабилитация.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Диспансерное наблюдение предусматривает **ежегодный** осмотр с оценкой эффективности терапии, слуховой и вестибулярной функции.

К мерам профилактики рекомендация относит формирование здорового образа жизни, раннее выявление воспалительных заболеваний ЛОР-органов, особенно у детей, и предупреждение рецидивов хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов посредством диспансерного наблюдения.

Рекомендации пациенту

1. избегать резких перепадов давления в среднем ухе: подводное плавание, резкое сморкание, авиаперелёты;
2. ограничить углеводы, солёные, острые и жирные мясные продукты; ежедневно включать в рацион продукты, богатые калием (печёный картофель, творог, курага);
3. исключить продукты с консервантами;
4. избегать переутомления, работы на высоте и с движущимися предметами.

Ограничения соли, глутамата натрия, алкоголя, кофеина и никотина приведены в разделе «Лечение» (диетотерапия).

5.1 Организация медицинской помощи

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-оториноларингологом в амбулаторных условиях.

Показания к госпитализации в оториноларингологическое отделение

1. тяжёлое состояние пациента;
2. тяжёлое течение: госпитализация бригадой скорой помощи напрямую в специализированное отделение, минуя амбулаторное звено.

Критерии выписки

1. прекращение или урежение приступов головокружения;
2. улучшение или стабилизация порогов слуха.

На течение и исход заболевания влияют его длительность и тяжесть, сопутствующая патология, возраст пациента, наличие и характер осложнений.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Болезнь Меньера»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «пересмотр не позднее 2026 года»; в приложении А2 — обновление каждые 3 года
Код в рубрикаторе	18_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность приступа указана неодинаково: в описании клинической картины «чаще 4-6 ч.», для первой стадии «в среднем от 1 до 3 часов», в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.
- Схема применения ацетазоламида приведена в таблетках, без указания дозы в миллиграммах.

- Для плановой инфузионной дегидратационной терапии (раздел 6) не названы препараты и не указаны УУР и УДД; уровни не указаны также для рекомендаций по хирургическому лечению и диспансерному наблюдению.